EPICRISIS MÉDICA

HOSPITAL	: HOSPITAL DE SAN CARLOS	N° EGRESO	: 84268
SERVICIO	: MEDICINA HSC		
FECHA	: 2024-05-10 09:40:00		

DATOS DEL PACIENTE:

Nombre	: ERNESTO CELIS RODRIGUEZ			RUN	: 5.630.517-3
F.Nac	: 31-10-1947	Edad	: 76 AÑOS, 6 MESES	Género	: Masculino
Dirección	:			Comuna	: SAN CARLOS
Previsión	: SIN INFORMACION	Teléfono	: 0		
Fecha Ingreso	: 23-04-2024	Fecha Egreso	: 2024-05-10 09:40:00	Causal	: MEDICA
Condición	: VIVO	Destino	: HOSPITALIZACIÓN DOMICILIARIA	Derivación	:

DIAGNOSTICO(S) INGRESO

1. R63.4-PERDIDA ANORMAL DE PESO.

DIAGNOSTICO(S) EGRESO

-Hemorragia temporal derecha + HSA silviana y sulcal temporo-parietal derecha
-ACV isquémico fronto temporo parietal izquierdo
-Bacteriemia por Streptococcus Anginosus en tratamiento finalizado
-Aneurisma obs micótico M2 postero-inferior derecho
-Obs Crisis convulsiva sintomática
-DHE: Hipernatremia en vías de resolución
-AKI Kdigo 1 resuelta
-Valvuloplastia mitral
-UPP sacra
-Hipoalbuminemia

DIAGNÓSTICOS CIE10

1. I60-HEMORRAGIA SUBARACNOIDEA. (DIAGNÓSTICO PRINCIPAL)
2. I64-ACCIDENTE VASCULAR ENCEFALICO AGUDO, NO ESP.COMO HEMORRAGICO (DIAGNÓSTICO SECUNDARIO)
3. A40.9-SEPTICEMIA ESTREPTOCOCICA, NO ESPECIFICADA (DIAGNÓSTICO SECUNDARIO)
4. I67.1-ANEURISMA CEREBRAL, SIN RUPTURA (DIAGNÓSTICO SECUNDARIO)
5. E87.0-HIPEROSMOLARIDAD E HIPERNATREMIA. (DIAGNÓSTICO SECUNDARIO)
6. S31.0-HERIDA DE LA REGION LUMBOSACRA Y DE LA PELVIS (DIAGNÓSTICO SECUNDARIO)
7. E46-DESNUTRICION PROTEICOCALORICA, NO ESPECIFICADA (DIAGNÓSTICO SECUNDARIO)

COMENTARIO DE EVOLUCIÓN / COMPLICACIONES

Paciente monorreno derecho, postrado, con escaras sacras y talares izquierdas, es traido a SU el dia 23/04 familiar refiere postración desde el 18/02 además de inapetencia, disnea, desaturación refiere que no quiere recibil alimentos por boca desde hace 2 dias, se aprecia en malas condiciones generales, se realiza tac de encefalo durante urgencias que informa lesión hemorrágica con hematoma intraparenquimatoso agudo corticosubcortical temporoparietal derecho con moderado edema perilesional que determina efecto de masa sobre los surcos adyacentes. Presenta vaciamiento subaracnoídeo con hematocisterna silviana y HSA sulcal. Hidrocefalia supratentorial con dilatación de cuernos temporales. Al examen físico de ingreso se

aprecia a paciente en malas condiciones generales glasgow 9 pts, piel pálida tibia a distal bien perfundido, enflaquecido, yugulares planas tórax simétrico sin uso de musculatura accesoria, abdomen bdi, M1 EESS y EEII, con LLP grado 1 en zona sacra, con lpp en talon izquierdo. paciente durante hospitalizacion presenta tos con expectoracion purulenta, se realizan cultivos, dando positivo para Streptococcus Anginosus, iniciando tratamiento con ampicilina por 14 dias segun antibiograma, finalizado el dia de hoy, TAC de cerebro control con isquemia extensa de todo el territorio de A. cerebral media izq, se plantea posibilidad de endocarditis infecciosa por lo que se solicita ecocardiograma, que es diferido dadas condiciones clínicas de paciente, en cuanto a lo clinico, secreciones bronquiales en disminucion, función renal y electrolitos persisten discretamente elevados. Paciente evoluciona en condiciones clínicas de cuidado, HDN estable, eupneico, afebril, estacionario en lo neurológico. presento retención aguda de orina varias veces que amerito sondaje intermitente, actualmente alimentandose via SNG. Dada evolucion de paciente, se conversa con familiares sobre mal pronostico y gravedad del caso, planificando una vez terminados los 14 dias de ABT, el dia de hoy, paciente recibirá cuidados en domicilio. se indicara alta con HODOM para inicio de cuidados y educacion a familiar sobre seguimiento.

PLAN DE MANEJO:

- Antibioticoterapia finalizada, se conversa con familiar dada condicion de paciente, para continuar manejo en domicilio, se enviara con HODOM para inicio de cuidados en domicilio.

INDICACIONES AL ALTA

1. - Reposo absoluto. Prevenir UPP (cambios de posición cada 3-4 horas, colchón antiescaras).
2. - Regimen por Glucerna 40 cc/h + agua libre a razon de 60cc/hr por SNG
3. - continuar KNTM+KTR con aspiración de secreciones bronquiales en caso de requerir por HODOM
4. - MAE
5. - Levetiracetam 500mg 1 comprimido am y 0.5 comprimidos p.m
6. - Paracetamol 500mg 2 comprimidos c/8 horas por SNG
7. - Bromuro de ipatropio 2 puff c/6 horas
8. - fluticasona/salmeterol 1 puff c/24 horas
9. - ETT Diferido
10. - Iniciar cuidados por HODOM + educacion a cuidador para continuar soporte

EXÁMENES Y RESULTADOS

09/05/24 creat 1.70 ELP 148/4.3/121 PCR 160.2
07/05/24 creat 2.10 ELP 148/ 4.9/123
05/05/24 Glic 115 creat 1.90 ELP 151/5.20/124 PCR 40.2 lact 1.0
03/05/24 Glic 130 Creat 1.60 ELP 149/3.70/122 PCR 50.8 Uremia 129 lact 0.9
01/04/24 Creat 1.30 ELP 149/3.7/119
30/4/24 Glic 106 Creat 1.20 lactato 0.6 PCR 58.6 Uremia 97 ELP 152/3.40/124
28/4/24 Creat 1.20 PCR 51.0 ELP 152/3.6/125
Hemocultivos 1-2 + para S. HCT 1-2 + para S. Anginosus
CSB E. Coli MS
26/4/24 Creat 1.40 Alb 2.2 lact 0.9 PCR 65.3 ELP 152/3.30/126 Hb 6.1 Hto 19.1 Plaq 179000 Leuc 14500

Claudia Paola Rivas Pacheco
MEDICO TRATANTE
27781954-6

JEFE SERVICIO